ยาต้านพิษ (Antidotes)

ชื่อยา	ข้อบ่งใช้	ขนาดยา
N-Acetylcysteine **ใช้น้ำหนักจริง ไม่เกิน 110 kg ในการคำนวณขนาดยา**	-Paracetamol overdose -ภาวะตับอักเสบจากสารพิษ	Oral: เริ่ม 140 mg/kg ตามด้วย 70 mg/kg ทุก 4 h อีก 17 ครั้ง ควรบริหารยาซ้ำ หากผู้ป่วยอาเจียนภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากบริหารยา IV: **ผู้ใหญ่ (≥ 40 kg):** NAC 150 mg/kg + D5W 200 ml in 1 h ⟶ NAC 50 mg/kg + D5W 500 ml in 4 h ⟶ NAC 100 mg/kg + D5W 1,000 ml in 16 h **เด็ก (20-40 kg)** : NAC 150 mg/kg + D5W 100 ml in 30 min ⟶ NAC 50 mg/kg + D5W 250 ml in 4 h ⟶ NAC 100 mg/kg + D5W 500 ml in 16 h **เด็ก (<20 kg):** NAC 150 mg/kg + D5W 3 ml/kg in 30 min ⟶ NAC 50 mg/kg + D5W 7 ml/kg in 4 h ⟶ NAC 100 mg/kg + D5W 14 ml/kg in 16 h **กรณีมีภาวะตับอักเสบ:** NAC 150 mg/kg + D5W 1,000 ml in 24 h บริหารต่อเนื่องจนกระทั่งภาวะพิษต่อตับของผู้ป่วยดีขึ้น (เอนไซม์ตับลดลง <1,000 IU/L)
Activated Charcoal	ยับยั้งหรือลดการดูดซึมยาหรือสารพิษ	First dose: 1 g/kg หรือ 10 เท่าของน้ำหนักสารพิษที่ได้รับ Repeated dose: 15-20 g ทุก 4-8 ชม.
Antivenoms	ใช้แก้พิษงู	งูที่มีพิษต่อระบบประสาท: งูเห่า 10 vials, งูสามเหลี่ยม, งูจงอาง 5-10 vials, งูทับสมิงคลา 5 vials, เซรุ่มรวมระบบประสาท เริ่มต้นอย่างน้อย 2 vials งูที่มีพิษต่อระบบโลหิต: งูเขียวหางไหม้ 3 vials, งูกะปะ 3-5 vials, เซรุ่มรวมระบบโลหิต เริ่มต้นอย่างน้อย 2 vials
Benztropine	ภาวะ EPS จากยา	ผู้ใหญ่: 1-2 mg IV เด็ก (>3 ปี): 0.02 mg/kg IV (Max: 1 mg)
Calcium Folinate (Leucovorin calcium)	ภาวะพิษจาก Methotrexate (MTX)	Lexicomp: 10 mg/m^2 q 6 hr ทันที จนกว่าระดับยา MTX <0.01 micromol/L ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี: **กรณีทราบปริมาณ MTx**: ให้เท่ากับปริมาณ MTx ที่ได้รับหรือมากกว่า ภายใน 48 ชั่วโมง **กรณีไม่ทราบปริมาณ MTx:** ให้ 75 mg ภายใน 12 ชั่วโมง (เด็ก 10 mg/m^2/ครั้ง) ตามด้วย 12 mg ทุก 6 ชั่วโมง 4 ครั้ง
Diphenhydramine	ภาวะ EPS จากยา	ผู้ใหญ่: 25-50 mg PO เด็ก: 0.5-1 mg/kg PO โดยให้ทุก 4-6 ชม. เป็นเวลา 2-3 วัน เพื่อป้องกันเป็นซ้ำ (Max: 400 mg/day ในผู้ใหญ่ หรือ 300 mg/day ในเด็ก)
Idarucizumab	พิษจาก Dabigatran	2.5 g iv push นาน 5-10 min x2 vials (ฉีด 2 vial ต่อเนื่องกัน ห่างกัน <15 min)
Methylene blue	ภาวะ Methemoglobinemia	1-2 mg/kg (0.1-0.2 ml/kg of 1%solution) slow IV push in 5 min จากนั้น 30-60 นาที ถ้ายังมีอาการหรือมี methemoglobin >30% ให้ยาซ้ำในขนาด 1 mg/kg หากให้ methylene blue 2 dose แล้วยังไม่ดีขึ้น ควรพิจารณาทางเลือกอื่นในการรักษา
Naloxone	พิษจากการใช้ยากลุ่ม opioids เกินขนาด	ผู้ใหญ่: **กรณี opioid non-dependence:** IV 0.4-2 mg และซ้ำทุก 2-3 นาที **กรณี opioid dependence:** IV 0.1–0.2 mg และซ้ำทุก 2-3 นาที (แนะนำเริ่มที่ขนาดต่ำ ๆ เพื่อป้องกัน acute withdrawal) **ถ้ายังไม่รู้สึกตัวหลังให้ยาไปแล้วรวม 10 mg อาจไม่ใช่ภาวะเป็นพิษจาก opioid เด็ก: 0.01 mg/kg IV bolus จากนั้นปรับขนาดเป็น 0.1 mg/kg โดยให้ซ้ำทุก ๆ 2-3 นาที (Max: 2 mg/dose)
Neostigmine	แก้ฤทธิ์กลุ่มยาดมสลบ	0.03-0.07 mg/kg (Max: 5 mg) IV push in 1 min โดยใช้ร่วมกับ Atropine
Pralidoxime (2-PAM)	พิษจากยาในกลุ่ม Organophosphates	Loading dose: 1–2 g (เด็ก 25-50 mg/kg, Max: 2 g) IV ช้าๆ 5-10 นาที (ไม่เกิน 200 mg/min ในผู้ใหญ่ และ 4 mg/kg/min ในเด็ก) หรือผสมใน NSS 100 ml IV drip in 15-30 min ให้ซ้ำได้ทุก 1 ชม. ถ้าอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงยังไม่ดีขึ้น หรือให้ Maintenance dose: 0.5-1 g/h (10-20 mg/kg/h) 48 ชม. แล้วค่อยลดขนาดยาลง
Protamine	พิษจาก Heparin หรือ Enoxaparin เกินขนาด	Heparin: 1 mg of Protamine to 100 unit of Heparin (Max: 50 mg/dose) Enoxaparin: 1 mg of Protamine to 1 mg of Enoxaparin (Max: 50 mg/dose)
Sodium nitrite	พิษจาก Cyanide	ผู้ใหญ่: 300 mg slow IV rate 2.5-5 ml/min เด็ก: 10 mg/kg[1] หรือ 6 mg/kg[2] slow IV rate 2.5-5 ml/min (Max: 300 mg) **เมื่อใช้ Sodium nitrite รักษาอาการพิษจาก cyanide ให้ใช้ร่วมกับ Sodium thiosulfate เสมอ โดยให้ Sodium thiosulfate ตามหลัง Sodium nitrite ทันที**
Sodium thiosulfate	พิษจาก Cyanide	ผู้ใหญ่: 12.5 g IV infusion >10-30 min โดยไม่ต้องเจือจาง เด็ก: 400 mg/kg[1] หรือ 250 mg/kg[2] IV infusion >10-30 min โดยไม่ต้องเจือจาง

References:
1.) ยาต้านพิษ 1-5 (Antidotes). สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย. 2554. 2) Lexicomp ®. 2021 [Database on application] cited; 25/8/2021.